ESE Hospital Sintético San Jerónimo

Código de habilitación 230010999903 · HISTORIA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL PACIENTE

USUARIO: PAOLA MARIANA PINEDA ORTIZ DOCUMENTO: CC 32003385 EDAD: 71 años SEXO: FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO: 04-07-1954 PROCEDENCIA: Magangué DIRECCIÓN: Calle 33 # 24-37

TELÉFONO: 320 962 7136 ASEGURADORA: Sanitas HISTORIA: HC-2026-2198 EPISODIO: ADM-499715

FECHA DE INGRESO: 24-03-2026 15:01 SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

«No puedo respirar bien y tengo las piernas hinchadas».

ENFERMEDAD ACTUAL

Disnea progresiva de una semana hasta hacerse de reposo, ortopnea de tres almohadas y edema de miembros inferiores. Ganancia de 4 kg en 10 días.

Según refiere su familiar Yaneth Pedro Burgos Navarro, el cuadro empeoró en las últimas horas.

ANTECEDENTES

Personales: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hipertensión arterial. Familiares: sin relevancia. Alérgicos: niega.

EXAMEN FÍSICO

TA 160/100 mmHg, FC 104 lpm, FR 26 rpm, SatO2 89 % al aire ambiente, T 36,4 °C. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema grado III en miembros inferiores.

ANÁLISIS

Falla cardíaca descompensada con congestión pulmonar y sistémica. Se hospitaliza.

DIAGNÓSTICOS

- I500 Insuficiencia cardíaca congestiva
- I10X Hipertensión esencial

ÓRDENES

- Péptido natriurético, creatinina, electrolitos.
- Radiografía de tórax.
- Toracentesis diagnóstica.

RESULTADOS

- Péptido natriurético tipo B: 1.850 pg/mL. Interpretación: Confirma falla cardíaca descompensada.
- Radiografía de tórax: cardiomegalia y redistribución de flujo. Interpretación: Congestión pulmonar.

PLAN DE MANEJO

- Furosemida 40 mg intravenosa cada 8 horas.
- Oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto.
- Restricción hídrica a 1.200 mL por día y control de peso diario.
- Enalapril 10 mg vía oral cada 12 horas.

EVOLUCIÓN

22-03-2026 13:07 · Día 2: Mejoría de la disnea, diuresis 2.400 mL en 24 horas, peso 2 kg menos. Se continúa

diurético intravenoso.

26-03-2026 14:33 · Día 3: Sin ortopnea, SatO2 94 % al aire ambiente, edema grado I. Se pasa furosemida a vía oral.

EPICRISIS

27-03-2026 11:53 · Día 4: Egreso con mejoría clínica. Diagnósticos de egreso: insuficiencia cardíaca congestiva descompensada e hipertensión arterial. Plan: furosemida 40 mg vía oral cada 12 horas, enalapril 10 mg cada 12 horas, control por cardiología en 15 días, signos de alarma explicados.

PROFESIONAL

Atendido por: Sandra Martha Arrieta Ojeda. Registro médico: RM-24076. Especialidad: Medicina interna. Firma electrónica registrada.

Fecha y hora de la anotación: 24-03-2026 15:01